真菌性角膜溃疡：病损切除联合伏立康唑

2026 单篇研究 · 正面

研究人群

23例回顾性病例系列，非指南。中央/旁中央，浸润≤1/2角膜厚度；抗真菌治疗3~7 d无明显好转。

2026 刊p122–123

诊断与排除

培养/涂片/共焦任一见菌丝或孢子。排除全层穿孔、眼内炎、凝血疾病和控制不佳严重全身病。

2026 刊p123

术前用药记录

氟康唑0.2 g静滴每日一次；5%那他霉素、10 g/L氟康唑滴眼液各每小时1次。仅为本文方案。

2026 刊p123

切除与注药记录

切除深度≤基质层1/2；边缘超0.5 mm。原文伏立康唑10 g/L、30G、多点基质注射，留针10秒；总量未明确。

2026 刊p123

真菌性角膜溃疡：病损切除联合伏立康唑

2026 单篇研究 · 背面

术后处理

局部抗真菌降至4~6次/d；每日观察愈合/再浸润。再浸润用结膜下注射伏立康唑，剂量原文未明确。

2026 刊p123

本文观察结果

21/23有效控制，愈合5~17 d；2例再浸润。随诊最终均愈合，未因感染加重移植；总治疗约90 d。

2026 刊p123

随访与风险

复查矫正视力、共焦、角膜愈合。1例白内障、2例远视漂移。统一复诊间隔及停药标准未明确。

2026 刊p123

使用边界

无对照、小样本、短随访；原文数据存在不一致。不可据本文浓度补造体积或推广至深层/穿孔病例。

2026 刊p123–125